

Väikesest suureks – kas jõult või mõistuselt? 2017. a haldusterritoriaalse reformi mõju omavalitsuste hoolekandele



Jüri Kõre, PH.D

sotsiaalpoliitika lektor, Tartu Ülikool

Koostöös Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppe üliõpilastega valminud valikuline analüüs haldusterritoriaalse reformi mõjudest esmatasandi hoolekandele keskendub neljale peamisele teemale: sotsiaalhoolekande korraldus ja personal; toetused ja teenused; hoolekande rahastamine; kogukonna (uuesti) määratlemine.

Sissejuhatus

Haldusreform (ja haldusterritoriaalne reform kitsamalt) on viimase veerandsajandi jooksul olnud üks kõige rohkem tähelepanu pälvinud halduspoliitika küsimusi Eestis. Vaidluste kõrval omavalitsuspoliitika üle on jäänud märkamata tõsiasi, et omavalitsus kui iseseisev haldustasand ja sotsiaalhoolekanne kui selgelt piiritletud ühiskonnakorralduse valdkond on meil tegelikult n-ö põlvkonnakaaslased. Mõlemad pärinevad 1990. aastate algusest: kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) 1993. ja esimene sotsiaalhoolekande seadus (SHS) 1995. aastast. Seega mõjutasid omavalitsuskorralduse senised nõrkused hoolekannet ning uute üksuste tugevused peaksid jõudu lisama ka sotsiaaltööle.

Käesolev valikuline analüüs haldusterritoriaalse reformi mõjudest esmatasandi hoolekandele valmis allakirjutanu ja Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

magistriõppe üliõpilaste koostöös. Vaatluse all on omavalitsuste ühinemine Harju-, Hiiu-, Pärnu-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal. Uuringu käigus koostati grupitööna intervjuu kondikava ja tehti vastavalt võimalustele kas grupi- või individuaalintervjuud omavalitsuste hoolekandespetsialistidega. Intervjuud toimusid k.a mais ja juunis. Analüüs keskendub neljale peamisele teemale: sotsiaalhoolekande korraldus ja personal; toetused ja teenused; hoolekande rahastamine; kogukonna (uuesti) määratlemine. Paralleelselt spetsialistide küsitlemisega töötati läbi omavalitsuste koduleheküljed: omavalitsuse juhtimine, eelarve, ühinemisleping. Arvesse võttes tõsiasi, et tegelikult reform ikka veel kestab, on järelduste tegemine moodsat terminoloogiat („tõendus põhine”) kasutades praegu veel võimatu. Seetõttu on ka artikli järeldused üsna ettevaatlikud ja esitatud pigem tinglikus, mitte kindlas kõneviisis.

Lühidalt naabrite kogemustest

Värskeima ülevaate naabrite haldusterritoriaalse reformi peamistest aspektidest esitab kokkuseaduse G. Sootla hiljuti ilmunud artiklite kogumikus (Haldusreform 2017, 2018). Selles leiduvat kordamata nendimevaid, et Eesti 2017. a omavalitsuskorralduse uuendajatel on kasutada naabrite rikkalik kogemus. Kui jätta kõrvale omavalitsuse kui iseseisva haldustasandi taastamine Eestis, Lätis ja Leedus 1990. aastate alguses, siis oleme Balti mere ümbruse riikidest viimase veerandsajandi jooksul viimane kohaliku halduse reformija (Swianiewicz jt 2017). Leedu 1995. a reformi tulemuseks on 60 omavalitsust, 2018. a alguse andmetel oli keskmine elanike arv omavalitsustes 48 tuhat. Läti 2009. a reformitud omavalitsused on Eesti omadega samas suurusjärgus: 119 omavalitsust, keskmine elanike arv 16 tuhat; Eestis valdu-linnu 79, elanikke keskmiselt 17 tuhat.

Kui minna halduskorralduse kirjeldamisel detailsemaks, siis tuleb ilmsiks erinevusi nii vastutuses kui ka ülesehituses: Leedus on omavalitsuste vastutada ka siseturvalisus, tervishoid, ettevõtlus jms; 60 omavalitsusstaatusega territoriaalse üksuse sees eristatakse 500 naabruskonda (*seniūnija*). Eravestlustes on Leedu kolleegid avaldanud arvamust, et sotsiaaltöö korraldamiseks on Leedu omavalitsus liiga suur ja üks seda hoiakut toeta ka alates 2008. aastast ellu viidav detsentraliseerimispoliitika. Nimelt on aastatel 2005–2007 peetud läbirääkimiste tulemusel loodud Kaunase, Šiauliai ja Švenčionyse sees uued omavalitsusüksused (*Implementation ...* 2014). Leedu kolleegid rõhutavad veel asjaolu, et haldusterritoriaalse reformi võtmeküsimus-võtmesõna on kompetents – eri valitsemistasandite vaheline kompetentsi jagamine (loomulikult

koos vastava rahastusbaasi tagamisega) ning institutsioonide ametnike ja töötajate kompetentsi tõstmine (Astrauskas 2014). 2009. aastal langetati otsus luua omavalitsuste koosseisus tervisedendusega tegelevad bürood (Kalediene jt 2011). Omamata küll infot selle ettevõtmise tulemuslikkusest, kirjeldab see ootusi, mida Leedu omavalitsustele pannakse. Tervisedendus on valdkond, mille puhul Eestis on vastutus ja tegevused paika pandud väga ebamääraselt, kuid KOVid on seni olnud selles kindlasti tagasihoidlikud „tegijad”.

Lätis on pilt eelnevale vastupidine. Kui Eestis on ühe alternatiivina omavalitsuste liitmisele/liitumisele püütud (üsna väheseduga) arendada omavalitsuste koostööd, siis Lätis on kaks mõnevõrra vastandlikku halduskorraldust efektiivsemaks muutvat skeemi ühendatud ja 119 omavalitsust koondatud 29 koostööpiirkonda. Koostöö toimub ka sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamisel/korraldamisel. Lätlased on meiega sarnaselt kimpus riiklike ja kohalike hoolekandeteenuste konkreetse kliendi jaoks tervikuks sidumisega ja praeguse korralduse puudusi püütakse siluda koostööpiirkondade tasandil.

Haldusterritoriaalne reform ja hoolekande haldamine

Kuid tuleme nüüd analüüsi tulemuste juurde. Luhtunud 2000. a reformikatsel järel Eestis toimunud linnade-valdade vabatahtliku ühinemise esmane ja kõige käegakatsutavam kasu esmatasandi hoolekandele oli erialase halduse tugevdamine. Varasema ühe-kahe spetsialisti asemel (lisaks sotsiaaltöötajale oli vallavalitsuse koosseisus enamasti ka üks-kaks hooldustöötajat) loodi kõikjal sotsiaaltöö või sotsiaalhoolekande teenistus või osakond. Samasugune muutus toimus 2017. aastal. Ainsana eristub

analüüsitud omavalitsuste seas Lääneranna vald, kus sotsiaalhoolekannet ei korralda samanimeline, vaid hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond. Mõneti kodanikku eksitav on paaris omavalitsuses kasutatav nimetus sotsiaal- ja tervishoiuosakond. Kehtiv tervishoiuteenuste korraldamise seadus ei näe kohalikule omavalitsusele ette vastavat kompetentsi, st rolli tervishoiu juhtimisel, ning kohalikust eelarvest rahastatav tervishoiuteenuste ost on mahu mõttes marginaalne. Seega on omavalitsuse tasandi võimalused sellesse valdkonda sekkumiseks minimaalsed. Võib väita, et suhteliselt kõige tugevam on sotsiaalhoolekande administratsioon praegu saartel: Saaremaa valla sotsiaalosakonnas on koos kolme tähtajalise projekti juhiga kokku 29, Hiiu valla sotsiaalosakonnas 9 töötajat. Mandriga võrreldes suurem töötajate arv on tingitud saartel valitud haldusmudelitest: Saaremaal on haldamiseks küll paljude mandri omavalitsusega sarnane kesk- (valavalitsus) ja piirkonnatasandi (teenuskeskus) kombinatsioon. Mandriga võrreldes suurem sotsiaaltöötajate arv tuleneb sellest, et pea igas teenuskeskuses on sotsiaaltööspspecialistid. Hiiumaa suhteliselt suurem meeskond on komplekteeritud endistele valdadele osavalla staatuse andmise pinnal: igas osavallas on sotsiaaltöötaja, lisaks kahe osavallas ka hooldustöötaja. Magistrandid tituleerisid selle haldusmudeli 1,5tasandiliseks haldamiseks¹.

Sotsiaaltöötajate erialasest spetsialiseerumisest võib enam ilmselt laste hoolekanne ja lastekaitse, kuid tugevust saab juurde ka eakate ja puuetega inimeste töövaldkond.

Intervjueeritud spetsialistide selgituse järgi on teenuskeskuste sotsiaaltöötajate alluvussuhted korraldatud eri mudeleid järgides: esiteks sektoriaalse töökorralduse mudel, kus nii vallamajas kui teenuskeskuses olevad töötajad alluvad vallamajas istuval peaspetsialistile; teise variandi kohaselt on nad regionaalsete struktuuride iseseisva kompetentsi ja otsustusõigusega töötajad. Võimalik, et kasutusel on ka kolmas variant, st segastruktuur, mispuhul üks spetsialist on iseseisev, teine aga keskusest juhitud. Sellise võimalusega ei osatud uuringut planeerides arvestada ja vastavad täpsustavad küsimused jäid esitamata. Milline mudel on parim, seda võiksid arutada teoreetikud, aga tegelikult valib parima lahenduse välja ikkagi praktika. Magistrantidega peetud seminaris tekitas kõige elavam arutelu Hiiu valla juhtimismudel. Seda põhjusel, et osavald kui omavalitsuse sisene haldusstruktuur on KOKSis kirjeldatud, mis tähendab, et vähemalt mõtteliselt on osavallal olemas teatud otsustusõigus. Teenuskeskus, piirkonnakeskus vms nimega üksus on seaduses defineerimata ja nendes tegutsevaid sotsiaaltöötajaid oleks korrektne käsitleda vastava osakonna või teenistuse koosseisu kuuluvate spetsialistidena.

Uued loodavad sotsiaaltöötajate ametikohad kannavad lastekaitse-, laste hoolekande, eestkoste-, sotsiaalteenuste jms spetsialisti nimetust. Sõna „uus” on mõneti tinglik, sest ühes ühinevas vallas võis lastekaitsetöötaja olla iidsetest aegadest, teise või teiste valdade elanike jaoks on see aga uus ametnik. Kavas on luua ka märksa põnevamaid ametikohti: näiteks osakondade-ülene infotöötaja Viljandi vallas, kes peaks menetlema lihtsamaid avaldusi kogu omavalitsuse

¹ Mandri omavalitsustest on personaliga hästi varustatud Jõgeva vald: 13 tuhat elanikku, 15 sotsiaaltöötajat, sh osakonna juhataja ja üks peretöötaja (vähem kui tuhat elanikku ühe spetsialisti kohta).

kompetentsi piires. Silmas pidades seda, et toimetulekutoetuse määramine on rangelt eeskirjast lähtuv ja „masina”, st STARi programmi poolt kontrollitud tegevus, siis võib needki avaldused rahumeeli jätta infotöötaja lahendada. Kindlasti peaks aga selliselt kogunev teave majandusraskustes vms peredest jõudma tema arvutist sotsiaaltöötajate arvutitesse. Mis puudutab reformijärgset sotsiaaltöötajate arvu, siis siin joonistusid välja kõik kolm võimaliku varianti: töötajate arv jäi kas samaks, suurenes või vähenes. Käesolevas analüüsis oli rohkem neid variante, kus töökohtade arv ei muutunud. Selline tulemus võib olla seotud muuhulgas ühinemislepingus kokkulepituga.

Sotsiaaltoetused ja -teenused

Allakirjutanu on kord ise refereerinud Sotsiaalkindlustusameti (SKA) optimistlikku arvamust, et haldusterritoriaalse reformi järel on kõigis 79 omavalitsuses kasvõi formaalselt olemas kõik SHS nõutavad (13) kohalikku sotsiaalteenust (Kõre 2018). See optimism ei pruugi olla õigustatud. Küsides infot olemasolevatest, puuduvatest ja defitsiidiga (mahuliselt suurendamist vajavatest) teenustest, saime kõige selgemad vastused defitsiidi kohta. Rahuldamata on nõudlus sotsiaaltranspordi, tugisiku ja isikliku abistaja ning koduteenuse järele, mõnel pool vajaksid sotsiaalhoolekande kliendid hoopis paremaid elamistingimusi (näiteks teenustega majas vms). Mõneti võib arusaam, millist teenust on omavalitsuses vaja arendada, olla seotud 2016. aastal koostatud maakondade sotsiaalhoolekande arengukavadega (Sotsiaalteenuste arendamine maakondades 2016–2020, 2016). Analüüsi koostajad olid osalt tollased ja ka hetkel ametis olevad omavalitsuste sotsiaaltöötajad ning nad

esitavad uuesti samu seisukohti, mida kaks aastat tagasi. Pilt ei ole siiski nii ühtlane, kui kokkusurutud analüüsist võiks järeldada. Näiteks Hiiu vald pidas küsitavaks tugisiku ja isikliku abistaja teenuse arendamise vajalikkust, sest hetkel pole nende teenuste järele nõudlust. Samas on koduhooldajad väga üle koormatud ja puudu on Hiiumaa elanike arvu ja olemasolevat hooldekodu kohtade arvu silmas pidades ka päris tubli hulk üldhooldekodu kohtadest.

Rahuldamata on nõudlus sotsiaaltranspordi, tugisiku ja isikliku abistaja ning koduteenuse järele, mõnel pool vajaksid sotsiaalhoolekande kliendid hoopis paremaid elamistingimusi.

Praegust kohalikku teenusekorraldust „ilustab” see, et mitmed teenused on nii ääremaadel kui ka mõnes keskuses olemas tänu SKA projektile „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele”, milles pakutavad teenused on psühholoogiline, pere- ja võlanõustamine, tugisiku teenus jm. Plaani järgi lõppeb projekt 2018. a lõpus. Pole garantiid, et kõik praegused SKA rahastatavate teenuste pakkujad on järgmisel aastal kohalike eelarvete rahastusel. Kas defitsiitsete tugisiku-, võlanõustamis- jt teenuste osutamine jätkub? Eilse ja tänase teenusekorralduse võrdlus toob välja mitmeid mõtlemapanevaid seiku. Miks näiteks suurimal ühineval omavalitsusel on ühinemiseelsest ajast kaasa võtta ainul üks teenus, väiksemal aga kogu SHS ette nähtud pakett (2017. a 11 teenust)? Samasugune pilt vaatab vastu institutsionaalsete teenuste osas, kus suurima ja jõukaima liituja territooriumil ei olnud ühtegi ei era ega avalikku sotsiaaltöö institutsiooni, aga elanike arvult ja eelarvelt märksa väiksemad partnerid töid kaasavaraks mitu asutust (erinevat teenust)!

Ühinemislepingud, mis keskenduvad otsese haldamise ümberkorraldamise kõrval investeringutele, ei ole ülearu hoolekandesõbralikud. Kaudne kasu sotsiaaltööle on teenuskeskuste loomise kaudu maapiirkondade sotsiaaltöötajatele hea töökeskkonna kindlustamine. Teenuskeskusi on analüüsi andmetel põhiliselt kahte liiki: endistesse vallamajadesse paigutatud keskused (bürood) ja valla hallatavate asutuste ruumides asuvad keskused (koolimaja, päeva- või kogukonnakeskuse vms maja). Haldusreformi nõustanud eksperdid on vihjanud, et sugugi kõigil teenuskeskustel ei pruugi olla pikka tulevikku. Magistrandid pidasid perspektiivikamaks neid sotsiaaltöötajate töökohti, mis asuvad ühes majas mõne teenusepakkujaga. Sellesse kohta on olemas klientide vool, sõltuvalt asutuse profiilist on võimalik teha ennetavat tööd jne. Palju sõltub aga keskuse asukohast, st kas see asub teel maakonna vm linna või jääb uue valla äärealale. Hinnanguliselt igas neljandas-viiendas ühinemislepingus on sees lubadus renoveerida sotsiaalkeskus, hooldekodu, päevakeskus, ehitada lasteaia hoone ümber hooldekoduks vms. Samuti hakkasid silma kavatsused muuta seni ühe sihtgrupi teenistuses olnud institutsioon universaalseks, nii lastele, eakatele kui puuetega inimestele tegevusvõimalusi pakkuvaks asutuseks.

Ilmselt on paljude omavalitsuste elanike, sotsiaalteenuse kasutajate aktiivse arutelu objektiks täna ja ka homme teenuste hinnakujundus. Analüüs näitas hinnakujunduse suhtes omavalitsuste sarnaseid käitumusmustreid. Nimelt seda, et kus teenus oli eile tasuta, seal võib see täna olla juba (osaliselt) tasuline. Kus teenuse saamiseks kehtis eile kliendi omaosaluse nõue, seal on täna omaosaluse määr eilsega võrreldes tõusnud! Mõnel juhul võib kohata mehhaanilist

hinnakujundust, mille vastu energiliselt võitleb õiguskantsleri büroo. Näiteks on üks elava isiku koduhooldusteenuse omaosaluse määr erinev, sõltudes sellest, kas tal on või pole lapsi, st seadusjärgseid ülalpidajaid. Esimesel juhul madalam ja teisel juhul kõrgem. Selline käsitlus ei lähtu teenusesaaja tegelikust majanduslikust olukorrast, vaid mõnelgi juhul ilmselt valest eeldusest, et kaks põlvkonda käsutavad ühiseid ressursse.

Silmanähtav ja kergesti fikseeritav muutus on toimunud toetuste maksmises. Suhteliselt must-valge pilt, mille järgi väikesed omavalitsused olid varasemalt pigem universaalsete ja suuremad nii universaalsete kui ka vajaduspõhiste (sissetulekute suuruselt sõltuvate) toetuste maksjad, on kadunud. Lihtsustatult võib öelda, et peale on jäänud suuremates omavalitsustes kasutusel olnud mudel. Sõltuvalt kokkulepetest on uute hoolekandeline abi osutamise määruste ja toetuste loend tänaseks siiski vähemalt ühe-kahe toetuse liigi võrra pikem kui varasem pikim loend liitunud omavalitsustes. Ka toetuse määrad on üldjuhul liikunud ülespoole ja sealt leiame varasemast hoopis suuremaid numbraid. Järvamaa ei olnud meie uuringu objektiks, kuid sealne sünnitoetuste näide on üsna kõnekas. Niisiis on sünnitoetuse suurus Paide linnas 400, Järva vallas 650 ja Türi vallas 700 eurot. Nendest numbritest vaatab vastu ühtaegu nii omavaheline konkurents (võitlus maksumaksja pärast) kui ka kaudne konkureerimine riigi perepoliitikaga, 320 eurose riikliku sünnitoetusega. Viimast püütakse lääneriikides üldjuhul vältida, sest see ähmastab vastava valdkonna poliitikat. Maksumaksja poolehoid võidetakse pigem kohaliku maksu- (kohaliku tulumaksu määra) ja teenusekorralduse ning teenuste tariifide optimaalsel tasemel hoidmise teel.

Tõusnud on ka omastehooldajatele makstavat toetused. Kui näiteks puuetega lapse hooldajatoetuse riigi keskmine on pisut üle 50 euro, siis reformimata omavalitsustes ulatub sügava puudega lapse hooldajatoetus 2018. aastal 200 (Võru linn) ja liidetud omavalitsustes 250 euron (Tori vald).

Artikli piiratud maht ei luba süveneda vägagi mitmekesisesse vajaduspõhiste toetuste maailma. Sotsiaaltoetuste hindamisel on kõige üldisemaks kriteeriumiks see, et need peaksid saajaid aitama vältida või vältida süvavaesusest (Kuddo jt 2002). Kuna nii mõnelgi kohalikul vajaduspõhisel toetusel on pigem kriisiabi maik, siis ilmselt need ka nimetatud kriteeriumile ei vasta.

Sotsiaalhoolekande kulud kohalikus eelarves

Kõige raskem oli võrrelda sotsiaalkaitse kulutusi ja hinnata, kas 2018. aasta eelarve loob sotsiaaltöötajatele varasemaga võrreldes paremad võimalused oma ülesandeid täita või mitte. Mehhaaniline protsentide võrdlus – suuremal liitujal oli sotsiaalhoolekande kuludeks näiteks 6%, väiksematel 8% ja 10%, mis uues omavalitsuses tähendab „endiste väikeste” valdade elanike jaoks kehvema tingimusi – oleks liiga lihtne ja riskantne analüüsimise tee. Selgelt positiivse momendina saab seoses rahaga välja tuua sotsiaaltöötajate palkade ühtlustamise: varem madalamat palka maksnud valdade sotsiaaltöötajatele kehtestati kõrgem palkamäär. Intervjuueritid Põhja-Sakala valla esindaja sõnul on nende kõrgharidusega sotsiaaltöötaja palk tänaseks riigi keskmisel või sellest pisut kõrgemal tasemel. Eelarvete võrdlust raskendas ühelt poolt varasemalt kasutatud erinevad arvestuspraktikad, mistõttu 2017. aasta eelarved olid omavahel raskesti võrreldavad, ning 2018. a riigi toetuste suurenemisest tuleneva mõju

arvessevõtt. Seetõttu tuleb tunnistada, et korrektset võrdlust, kas hoolekande rahastamine kohapealset võimekust ja võimalusi parandas või mitte, ei õnnestunud teha. Intervjuueritid spetsialistid andsid küsimustele eelarve kohta kas poliitkorrektselt mittemidagiütlevaid või ebalevaid vastuseid. Üks intervjuueritu tunnistas, et vallas on neli institutsiooni, mis kasutavad ära suurema osa eelarve rahast (st mitteinstitutsionaalsete teenuste arendamiseks kehtib ilmselt piirang). Teine julges tunnistada, et tema arvates eelarve ei kasvanud (mis võib tähendada ka vähenemist). Siiski ei saa neist väljaütlemistest otseselt välja lugeda ohtu kohalikele hoolekandele. Kui Põhja-Pärnumaa põhitegevuse eelarvest moodustavad 2018. a sotsiaalkaitse kulud 14,6%, siis sõltumata varasemast seisust, mida me ei saanud teada, on protsent tublisti üle riigi keskmise.

Kus teenus oli eile tasuta, seal võib see täna olla juba (osaliselt) tasuline. Kus teenuse saamiseks kehtis eile kliendi omaosaluse nõue, seal on täna omaosaluse määr eilsega võrreldes tõusnud!

Väär oleks taandada omavalitsustasandi hoolekande rahastamist kohaliku eelarve kulutuste ümberjagamise vms aspektile. Riik on pannud kohalikele omavalitsustele kohustuse võidelda sotsiaalpoliitika vaatenurgast ühe peamise ülesande – vaesusega. Samas on KOV rolli mitmel põhjusel raske määratleda. Esiteks on eesmärk sätestatud üsna ebamääraselt selle nimel tegutsemise, mitte saavutamise või kohustusena. Teisalt on sama murega tegelev keskvalitsus mõnigi kord oma tegemistes ebajärjekindel. Selle tõenduseks on vajaduspõhiste peretoetuste maksmine aastatel 2013–2017: abi sai aastaskeskmiselt 5–6 tuhat isikut (leibkonda).

Rasvane rist, mis sellele toetusele 2017. a peale tõmmati, tähendab küll ürituse ebaõnnestumist, aga see on vähetõhusa poliitikameetme valiku, mitte lastega perede vaesusest pääsemise teema. Eespool tõdesime, et kohalikul tasandil makstavad toetused teenivad pigem maksumaksjate värbamise eesmärki. Isegi kui seda suundumust korrigeerida, tekib küsimus: mille arvel. Sotsiaalministeeriumi arvutuste järgi oli riigis sotsiaalkaitsele kulutatavast rahast omavalitsuste kasutada aastal 2009 4,4%, 2015. aastaks oli see vähenenud 3,4%ni. Kommentaarid on vist liigsed.

Kohalik identiteet ehk „uus kogukond“

Sotsiaaltöö käesoleva kümnendi üks võtmesõnadest ELis ja paratamatult ka Eestis on kogukonnatöö ehk teisisõnu kogukonna hoolekanne. Seetõttu on mõistetav, et püüdsime intervjuudes aimu saada suhtumisest uude valda kui territoriaalsesse kogukonda. Et teema ei ole sugugi tähtsusetu, seda tõendab kõige lihtsama näitena endise Ülenurme valla elanike protest liidetud omavalitsuse nimena Kambja nime kasutamise vastu.

Ükski intervjuueritu ei näinud ennast erinevate kogukondade liitjana. Kuid see roll tekib paratamatult siis, kui igapäevases tegevuses suureneb ennetava sotsiaaltöö osatähtsus.

Elanike vahel teatava uue ühtsustunde, omavahelise seotuse ehk kogukonnatunde kiiremaks tekkimiseks on loomulikult suurem võimalus vabatahtlikult, mitte sundliitmise teel tekkinud omavalitsustes. Siiski arvasid ka viimastena nimetatud üksustes intervjueeritud eksperdid, et noored on juba ennast häälestanud olema ja esinema uue valla lipu ja vapi all. Kogukonna

vanemal osal võtab see aega ja võimalik, et nende identiteediks on ja jääbki kuulumine omaeegse põllumajandus vm ettevõtte kollektiivi. Identiteedi kujundamisel omistasid sotsiaaltöötajad suurt tähtsust volikogule. Kas ja kuidas kaasatakse külavanemaid, seni enamasti endiste valdade piirides tegutsevaid seltse ja ühinguid jne. Kuigi kogukonna aktiviseerimine on üks sotsiaaltöötajate poolt kasutatav töömeetod, ei näinud ükski intervjuueritu ennast igapäevatoos erinevate kogukondade liitjana. Kuid see roll tekib paratamatult siis, kui igapäevases tegevuses suureneb ennetava sotsiaaltöö osatähtsus.

Magistrantide ühise arutelu tulemusena kujunes välja seisukoht, et kõige raskem on uue kogukonna väljakujunemine geograafiliselt piiritletud omavalitsustes (põhja-, lääne- jne vald). Nimetus Põhja-Pärnumaa vald rõhutab iseenesest pigem maakondlikku identiteeti ja „kustutab“ mujal Eestimaal elavate inimeste mälust seosed üsnagi tuntud Vändra vm valla suurema asulaga. Lääneranna valda ei pruugi aga maateaduses nõrk Eesti elanik isegi maakonna täpsusega paika panna.

Kokkuvõtteks

Esimesele etapile joone alla saanud haldus-territoriaalse reformi tulemuste või mõjude analüüs ei saa olla midagi muud kui mõnede plusside ja miinuste väljatoomine.

Plusside poolele saab kindlasti kirjutada kohalikul tasandil varasemate üksikute ametikohtade asemel sotsiaalhoolekande osakondade või teenistuste loomist. Sel moel tugevneb sotsiaaltöö positsioon nii omavalitsuse sees kui ka avaliku halduse süsteemis tervikuna. Ebaselge on teenuskeskuste ja nende koosseisus olevate sotsiaaltöötajate ametikohtade perspektiiv. Ilmselt pole aga hoolekandes teisiti, kui praktikas järele proovides, võimalik keskust ja tagamaad ühendavat töökorralduse mudelit luua.

Teiseks plussiks on kahtlemata sotsiaaltöotajate erialane spetsialiseerumine, milleks omavalitsuste liitumine lõi võimaluse. Enim võidab sellest ilmselt laste hoolekanne ja lastekaitse, kuid tugevust saab juurde ka eakate ja puuetega inimeste töövaldkond. Selge plussi või miinuse kirjapanek on keerule olulistes sisulistes valdkondades: teenuste korraldus ja toetuste maksmine ning sotsiaalkulutuste maht. Kuigi vormiliselt võib kõigis uutes omavalitsustes olla SHSes nõutavate teenuste loend olemas, nõuavad mitmed selle loetelu teenused (sotsiaaltransport, tugiisiku teenus, koduteenus) nii sisulist kui mahulist arendamist, omavahel seotud teenuste (omaste-, kodu- ja institutsionaalse hoolduse) proportsioonid korras- tamist, mõnel juhul teenuse, nt päevakes- kuse teenuse sisu täpsustamist. Mõnevõrra kompaktsemaks on muutunud sotsiaal-

toetuste „pakett”, varasemad erinevused rõhuasetustes, kas valdavalt universaalsed toetused või universaalsete ja vajaduspõhiste toetuste kombineerimine, on kadunud. Järeldust, et uute omavalitsuste eelarvetes on sotsiaalhoolekande osa kasvanud, ei ole võimalik teha. Ilmselt on see reformi järgmise etapi, KOV tulubaasi ja kompetentsi täpsus- tamise küsimus. Subjektiivse mulje põhjal on mitmelgi pool uute valdade uutel juhtidel eelnenutega võrreldes rohkem elanike poo- lehoidu. Kuid sotsiogeograafilist reaalsust st tõmbekeskuste piire eirav sundliitmine ning põhja-, lääne- jms liiteid sisaldavad val- lanimed ei toeta mingilgi moel ühise kogu- konnainidentiteedi kujunemist. See tuleb on käesoleval hetkel kindlasti kõige nähtavam haldusterritoriaalse reformi miinus ja sun- nib sotsiaaltöötajaid pingutama mõistele kogukonnatöö sisu andmise nimel. **S**

Artikli aluseks oleva materjali kogumisel ja analüüsimisel osalesid TÜ sotsiaaltöö ja sot- siaalpoliitika magistriõppe üliõpilased Eleriin Aalde, Meili Heero, Kelli Ilisson, Robin Aleks Jõgi, Anneli Kondrad, Karen Pauliin Konks, Liina Lelov-Aasmaa, Hele Plakso ja Eda Rannamägi.

Viidatud allikad

- Astrauskas, A.** (2014). Local Self-Government in Lithuania in 1990–2013: Changes of the Competence of Municipalities. *Public Policy and Administration*, Vol 13 No 2, 187–208.
<https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/1607> (30.08.2018)
- Implementation experience of administrative territorial reform in Lithuania.** (2014). Ministry of the Interior of Republic of Lithuania.
www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/LITHUANIA_Rasa-Dalia-LIUTKEVICIENE_25-Sept-2014_ENG.pdf (30.08.2018).
- Kalediene, R., Ščeponavičius, A., Kavaliūnas, A., Ašoklienė, L.** (2011) Public health bureaus: new players in health improvement in Lithuania. *Acta Medica Lithuanica* Vol. 18. No. 4. 183–189.
- Kuddo, A., Leppik, L., Leetmaa, R., Luuk, M., Võrk, A.** (2002). Sotsiaaltoetuste efektiivsus ja mõju tööjõupakkumisele. www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2002-Sotsiaaltoetuste-efektiivsus-ja-moju-toojoupakkumisele.pdf (30.08.2018).

- Kõre, J.** (2018). Vaeste hoolekandest sotsiaalhoolekandeks. *Sotsiaaltöö*, 20. aasta juubeli erinumber, 42–49.
- Sootla, G.** (2018). Haldusreform 2017. Artiklikogumik, toimetaja S. Valner, 301–320.
<https://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2018/07/haldusreform-2017.pdf> (30.08.2018).
- Sotsiaalteenuste arendamine maakondades 2016–2020*** (2016). Koondaruande koostaja A. Rasu.
[www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/
Sotsiaalteenuste_ja_toetuste_andmeregister_STAR/Lisainfo/mak_analuus_toimetatud.pdf](http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalteenuste_ja_toetuste_andmeregister_STAR/Lisainfo/mak_analuus_toimetatud.pdf)
(30.08.2018).
- Swianiewicz, P., Gendźwił, A., Zardi, A.** (2017). Territorial reforms in Europe: Does size matter? Territorial Amalgamation Toolkit. Tools for Local and Central Authorities.
<https://rm.coe.int/territorial-reforms-in-europe-does-size-matter-territorial-amalgamation/168076cf16>
(30.08.2018).